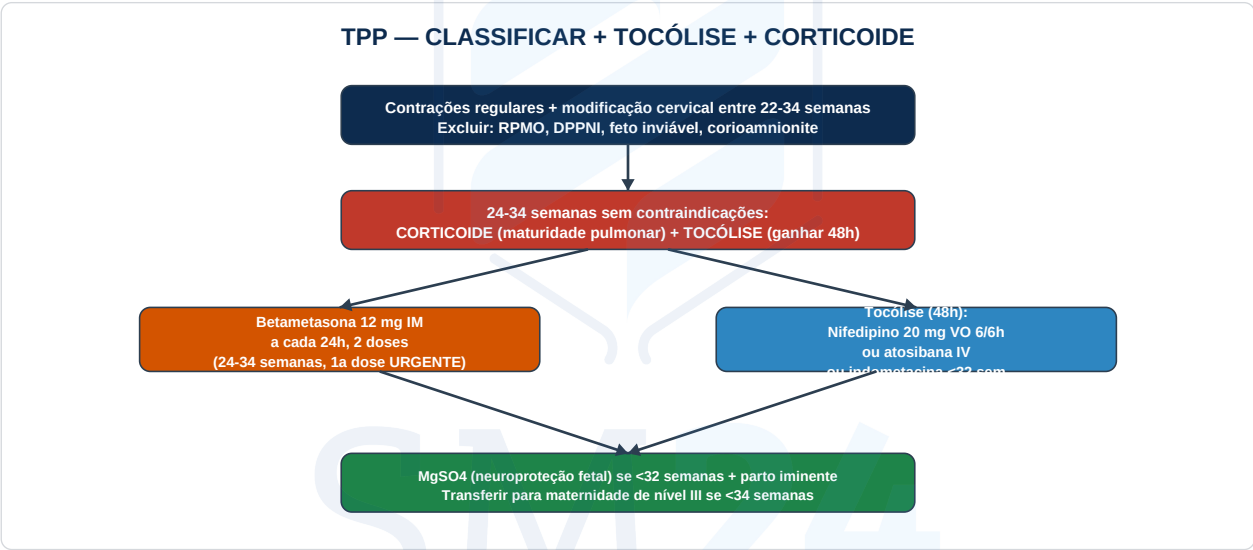


TPP — TOCÓLISE + CORTICOIDE + TRANSFERÊNCIA

DEFINIÇÕES E FATORES DE RISCO

Aspecto	Definição / Detalhes
Parto prematuro	Parto entre 22 e 36+6 semanas de gestação
Prematuro extremo	<28 semanas — mortalidade e morbidade neurológica severas
Prematuro tardio	34-36+6 semanas — maior risco de SDR, icterícia, hipoglicemia
Fatores de risco	TPP anterior (fator de risco mais importante), gemelar, colo curto (<25 mm), infecção, trauma, DPPNI, polihidrânio, tabagismo
Diagnóstico TPP	Contrações regulares (>=4/20 min ou >=8/60 min) + modificação cervical: dilatação >=2 cm OU apagamento >=80%
Fibronectina fetal (fFN)	Se negativa: VPP muito baixo para parto em 7 dias — pode evitar internação desnecessária

MANEJO DO TPP



TOCÓLISE — OPÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Droga	Dose	Contraindicações / Efeitos
Nifedipino	20 mg VO ataque; 10-20 mg 6/6h manutenção	Hipotensão materna; 1a escolha oral pela facilidade; bloq. Ca++
Atosibana	Bolus 6,75 mg IV + infusão 18 mg/h x 3h + 6 mg/h x 45h	Menos efeitos adversos; custo elevado; antagonista de ocitocina
Indometacina	50-100 mg VO/retal ataque; 25 mg 6/6h x 48h	Usar apenas <32 sem (risco fechamento precoce do canal arterial)
Terbutalina/ritodrina	IV ou SC — betamiméticos	Taquicardia, hiperglicemia — menor uso atualmente
EVITAR >34 semanas	Tocólise contraindicada após 34 semanas	Risco materno-fetal supera benefício; deixar evoluir o parto
CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS	Corioamnionite, DPPNI, anomalia fetal letal, sofrimento fetal	Não usar tocólise — parto deve ocorrer

CORTICOIDE — MATURIDADE PULMONAR FETAL

BETAMETASONA — DOSE ÚNICA MAIS IMPORTANTE NA OBSTETRÍCIA

- Betametasona 12 mg IM + 12 mg IM com 24h de intervalo (2 doses = ciclo completo)
- Indica entre 24-34 semanas + risco de parto em 7 dias
- Efeito: redução de SDR, hemorragia intracraniana e enterocolite necrosante
- Benefício mesmo com 1 dose: administrar imediatamente, não aguardar 2a dose para isso
- 34-36+6 semanas: pode considerar (dose única betametasona) — reduz SDR tardia
- Repita após 2 semanas SOMENTE se <32 semanas e risco ainda presente (controverso)

CORIOAMNIONITE — CONTRAINDICAÇÃO À TOCÓLISE

Diagnóstico de Corioamnionite

- Febre materna ($T \geq 38.0^{\circ}\text{C}$) + 2 dos seguintes:
- Taquicardia materna (>100 bpm)
- Taquicardia fetal (>160 bpm)
- Sensibilidade uterina
- Líquido amniótico purulento/fétido
- Leucocitose materna ($>15.000/\text{mCL}$)

Conduta na Corioamnionite

- NÃO tocólise — infecção ativa contraindica retardar parto
- ATB imediato: ampicilina 2 g IV 6/6h + gentamicina 5 mg/kg/d
- Adicionar metronidazol se parto por cesárea
- Resolução do parto: vaginal preferível; cesárea se indicação obstétrica
- Corticoide: administrar mesmo com corioamnionite se <34 semanas
- Recém-nascido: risco de sepse neonatal precoce — UCI pediátrica

ADMISSÃO NO PS — TPP

AVALIAR AO CHEGAR

- ☐ Idade gestacional exata: calcular por DUM + US precoce
- ☐ US obstétrico urgente: posição fetal, placenta, LA, colo (transvaginal)
- ☐ RPMO: amniotest ou pool de LA no fundo de saco + US (oligo ou anidramnia)
- ☐ Cardiotocografia: vitalidade fetal + padrão de contrações
- ☐ Laboratorial: hemograma, PCR, urocultura, GBS (estreptococo do grupo B) + swab vaginal/anal
- ☐ MgSO₄ neuroprotetor: 4 g IV em 20 min + 1-2 g/h se <32 semanas e parto iminente

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Gestante de 28 semanas com contrações regulares e dilatação de 3 cm. Sem febre, LA claro, CTG reativo. Qual conduta imediata?

- A) Cesárea de urgência imediata
- B) Alta com repouso domiciliar
- C) Betametasona 12 mg IM + tocólise (nifedipino) + MgSO₄ neuroprotetor
- D) Amniocentese para confirmar maturidade pulmonar
- E) Ocitocina para acelerar o parto e reduzir tempo de exposição

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a tocólise deve ser evitada em casos de corioamnionite?

- A) Porque causa bradicardia fetal
- B) Porque retardar o parto prolonga a exposição do feto e da mãe à infecção ativa
- C) Porque nifedipino é contraindicado na gestação
- D) Porque tocólise reduz a eficácia dos antibióticos
- E) Porque corioamnionite causa amadurecimento cervical e a tocólise é ineficaz

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o objetivo primário da tocólise no TPP?

- A) Evitar o parto prematuro definitivamente
- B) Ganhar 48h para completar corticoide e transferir para maternidade de nível III
- C) Tratar a causa do TPP
- D) Prevenir ruptura prematura de membranas
- E) Reduzir a contratilidade uterina por 30 dias

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Qual agente tocolítico deve ser evitado após 32 semanas pela possibilidade de fechamento prematuro do canal arterial?

- A) Nifedipino
- B) Atosibana
- C) Indometacina
- D) Terbutalina
- E) MgSO₄

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o benefício do sulfato de magnésio (MgSO₄) quando administrado antes de um parto prematuro iminente <32 semanas?

- A) Tocólise (retardar as contrações uterinas)
- B) Maturidade pulmonar fetal
- C) Neuroproteção fetal (reduz paralisia cerebral e hemorragia intracraniana)
- D) Tratamento da corioamnionite
- E) Prevenção de eclâmpsia neonatal

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

TPP em 28 semanas sem contraindicações: betametasona 12 mg IM (1a dose urgente — maturidade pulmonar) + tocólise (nifedipino — ganhar 48h para completar corticoide) + MgSO₄ 4 g IV (neuroproteção fetal <32 sem) + transferência para UTI neonatal de nível III.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Corioamnionite: infecção intra-amniótica ativa — retardar o parto mantém feto e mãe expostos a infecção que pode evoluir para sepse neonatal precoce e sépsis materna. Parto é o tratamento da corioamnionite. Tocólise contraindica absolutamente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Tocólise: objetivo é ganhar 48h para completar 2 doses de corticoide (betametasona) e transferir para maternidade de nível III. Não impede o parto definitivamente — apenas retarda. Após 48h de corticoide completo, pode suspender tocólise.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Indometacina (AINE): inibe prostaglandinas → contração do canal arterial → se usado após 32 semanas, risco de fechamento prematuro do canal arterial (HIPERTENSÃO PULMONAR fetal). Usar apenas <32 semanas por 48h. Acima: nifedipino ou atosibana.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

MgSO₄ como neuroprotetor fetal: indicado <32 semanas com parto iminente. Reduz risco de paralisia cerebral em 30-40% e hemorragia intracraniana grave. Mecanismo: neuroproteção dos neurônios pelo bloqueio de receptores NMDA. Dose: 4 g IV em 20-30 min + 1-2 g/h.

SM24
Suporte ao Plantão Médico